

# Un adulte autiste âgé que vous accompagnez à domicile

Pour les aides à domicile, les assistants personnels et le personnel de soutien communautaire — soutenir un adulte autiste âgé (environ 60 ans et plus).

## L'idée principale

L'autisme, à travers le **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adulte âgé s'est toujours verrouillée dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Beaucoup d'adultes autistes âgés n'ont jamais été identifiés et portent le poids d'une vie de masking et de besoins non comblés. Vos visites sont peut-être la relation la plus prévisible et la plus acceptante de leur semaine. Protégez les routines, les intérêts et les objets de toute une vie ; réduisez la charge sensorielle ; communiquez littéralement ; et surveillez le burnout et la douleur que le fait de « ne pas se plaindre » peut masquer.

## Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

| Vous pouvez observer...                                      | Ce qui se passe souvent                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Même routine, mêmes objets, mêmes intérêts — à chaque visite | La prévisibilité et le flux sont une <b>régulation et une identité</b>                         |
| Évite les soins, annule, « n'aime pas quand vous venez »     | Expériences négatives tout au long de la vie + barrières sensorielles/de communication         |
| Réponses lentes ou inhabituelles ; semble confus             | Souvent un temps de traitement + différence autistique — <b>pas nécessairement une démence</b> |
| Ne signale pas la douleur ou les symptômes                   | Différences d' <b>intéroception</b> ; « ne pas se plaindre » ≠ « ne pas souffrir »             |
| Retiré, épuisé                                               | Possiblement des décennies de <b>burnout</b> accumulé                                          |

## Essayez ceci

- **Soyez la présence prévisible et acceptante** — même personne, même heure, même plan ; prévenez avant tout changement.
- **Protégez les routines, les intérêts et les objets de toute une vie** — les supprimer « pour la sécurité » peut causer un réel préjudice.
- **Communiquez clairement, littéralement et lentement**, par écrit quand cela peut aider ; laissez un temps de traitement suffisant.
- **Réduisez la charge sensorielle** et tenez compte des changements de l'audition ou de la vision qui s'ajoutent aux différences chroniques.
- **Interrogez-les proactivement sur la douleur et les symptômes** — n'attendez pas qu'ils en parlent.

## Évitez ceci

- Perturber les routines ou supprimer des objets familiers.
- Supposer que la lenteur ou un style différent signifie un déclin cognitif — évaluez, ne supposez pas.
- Assimiler un calme ou une apparence « stable » au fait d'aller « bien ».

## Quand chercher plus de soutien

Surveillez le **burnout autistique** (souvent le fruit de plusieurs décennies) et l'**isolement social** (un risque majeur). La question **démence ou différence ?** est difficile et sous-étudiée — signalez les changements avec bienveillance et demandez une évaluation informée sur l'autisme plutôt que de supposer. Signalez toute nouvelle détresse comme un possible signal d'alarme médical.

## If the person is a woman

Les femmes autistes âgées sont un groupe particulièrement sous-identifié, ayant pratiqué le masking toute leur vie ; des antécédents d'« anxiété » ou de burnout parallèlement à une différence chronique justifient un examen sérieux de l'autisme.

## À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour la famille** (Partie 5), le **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Partie 3.5) et la brève sur le **Monotropisme**. Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Les preuves sur le grand âge sont rares ; adaptez-le à l'individu.

**Sources clés.** Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, aging & autism); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); OAR (aging on the spectrum). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.